

УДК: 616.351-006.6:615.277

А.К.Туманова, М.А.Кузикеев, С.Е.Есентаева, С.В.Лаишул, А.И.Джуманов
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Промежуточные результаты изучения эффективности неоадьювантной химиотаргетной терапии рака прямой кишки

Аннотация. Данная работа посвящена изучению значения таргетного агента в неоадьювантном периоде лечения рака прямой кишки. Получены промежуточные данные о непосредственной эффективности и побочных эффектах химиотаргетной терапии препаратами: иринотекан + фторурацил/натрия фолинат, бевацизумаб.

Ключевые слова: колоректальный рак, химио-таргетная терапия.

Актуальность

Ежегодно в мире регистрируют более 1 миллиона случаев колоректального рака [1]. В большинстве стран мира смертность от рака прямой кишки (РПК) занимает 5-6 места [2]. Вопрос повышения эффективности лечения при этом заболевании приобретает с каждым днем все большую актуальность. Многочисленные исследования посвящены оптимизации основополагающих методов терапии - лекарственного, хирургического и лучевого.

В арсенале химиотерапевтов сегодня схемы на основе фторпиримидинов, иринотекана, оксалиплатина.

Последнее десятилетие характеризуется появлением и быстрым развитием нового направления лекарственной противоопухолевой терапии – таргетной терапии.

Моноклональные антитела и низкомолекулярные препараты являются наиболее широко применяемыми методами для подавления ангиогенеза. Эффективность этих антиангиогенных средств была доказана, как в доклинических, так и клинических условиях. Хотя ангиогенез играет важную роль в заживлении ран, и других физиологических процессах, торможение ангиогенеза кажется относительно безопасным терапевтическим средством против рака, и поэтому исследованию в этой области посвящено значительное количество работ [3].

Работа Samalin E и соавторов [4] представляет собой ретроспективное исследование, посвященное эффективности комбинации бевацизумаба и FOLFIRI или FOLFOX для химиотерапии пациентов с метастатическим колоректальным раком, не ответивших на проводимую ранее химиотерапию на основе фторпиримидинов и иринотекана/ или оксалиплатина. Его результаты показали, что сочетание бевацизумаба с FOLFOX или FOLFIRI может активно использоваться в химиотерапии отдельных пациентов с метастатическим колоректальным раком [4]. Однако значение таргетного агента в неоадьювантном периоде радикального лечения рака прямой кишки еще на стадии изучения, чему и посвящена данная работа.

Цель исследования

Улучшение результатов лечения рака прямой кишки.

Материал и методы

В ходе I этапа исследования были включены больные раком прямой кишки – 8 человек в основную группу и в контрольную – 45. В основной группе было проведено комплексное лечение по схеме: FOLFIRI + бевацизумаб, 3 курса химиотаргетной терапии (ХТТ) каждые 2 недели с последующим оперативным лечением.

В контрольную группу вошли больные раком прямой кишки, получившие мультимодальное лечение в условиях Казахского НИИ онкологии и радиологии в рамках НТП 2009-2011 гг. по схеме: FOLFIRI, 3 курса + лучевая терапия, с последующим оперативным лечением. Основные характеристики клинического материала представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные характеристики больных раком прямой кишки

Признак абс.		Основная группа	
		%	
Пол	жен	3	37,5
	муж	5	62,5
Средний возраст		48±11,3	
Локализация (отдел прямой кишки)	нижнеампулярный	4	50
	среднеампулярный	3	37,5
	верхнеампулярный	1	12,5
Стадия заболевания	Duke' A	-	-
	Duke' B	3	37,5
	Duke' C	5	62,5
У р о в е н ь д и ф ф е р е н ц и р о в к и аденокарциномы	высоко	-	-
	умеренно	7	87,5
	низко	1	12,5

В таблице 2 показано распределение пациентов с РПК в зависимости от объема оперативного лечения.

Таблица 2 - Распределение больных раком прямой кишки по видам оперативных вмешательств

№	Вид оперативного вмешательства	Основная группа (n=8)
1	Передняя резекция прямой кишки	3 (37,5%)
2	Низкая передняя резекция прямой кишки	1(12,5%)
3	Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки	3 (37,5%)
4	БПЭ прямой кишки с формированием Э-образного резервуара	-
5	ПРПК с разгрузочной илеостомой	1(12,5%)
6	БАР прямой кишки с разгрузочной колостомой	-
7	Операция Гартмана	-

Таблица 3 – Показатели побочных эффектов химиотерапии в зависимости от метода лечения

Побочные эффекты	Степень	Основная группа (n=8)	
		абс.	%
Анемия	I	3	37,5±5,3
	II	1	12,5±2,5
	III	-	-
	IV	-	-
Лейкопения	I	2	25,0±2,8
	II	3	37,5±3,5
	III	-	-
	IV	-	-
Тромбоцитопения	I	3	37,5±3,8
	II	1	12,5±3,2
	III	-	-
	IV	-	-
Тошнота с эпизодами рвоты	I	1	12,5±2,0
	II	-	-
	III	-	-
	IV	-	-
Диарея	I	-	-
	II	2	25,0±2,8
	III	-	-
	IV	-	-
Токсический гепатит	I	-	-
	II	-	-
	III	-	-
Боли в эпигастрии	I	4	50,0
	II	1	12,5±2,3

Пациенты из основной группы химиотерапия прошли по 3 неoadъювантных курса ХТТ с перерывом 2 недели в режиме: FOLFIRI (ириротекан – 180 мг/м² в/в капельно в 1-й день, фторурацил – 400 мг/м² в/в струйно в 1-й день затем натрия фолиат – 400 мг в/в в 1-й день + фторурацил – 2,4-3,0 г/м² 48-часовая в/в инфузия) + бевацизумаб 5 мг/кг.

В контрольной группе в предоперационном периоде проводилось химиолучевое лечение в режиме: 3 курса FOLFIRI с перерывом 2 недели (ириротекан – 180 мг/м² в/в капельно в 1-й день, фолиат кальция – 200 мг/м² в/в в 1-й день, фторурацил – 400 мг/м² в/в струйно в 1-й день, затем фторурацил – 2,4-3,0 г/м² 24-часовая в/в инфузия), к 3 курсу ПХТ присоединялась лучевая терапия (облучение проводили на гамматерапевтическом аппарате в статическом режиме 3-мя полями: прямое (крестцовое) и два ягодичных (под углами 60°) СОД 50 Гр, РОД 2 Гр).

Таблица 4- Структура ранних послеоперационных осложнений у больных раком прямой кишки

Послеоперационные осложнения	Основная группа n=8
Нагноение операционной раны	1 (12,5%)
Несостоятельность энтеро-энтероанастомоза	-
Острая кишечная непроходимость	-
Эвентрация	-
Кровотечение в полости малого таза	-
Пневмония	-
Летальность	-

Таблица 5 – Показатели эффективности неoadъювантной химиотаргетной терапии у больных РПК

Количество больных	Степень регрессии опухоли (%)			
	полная	частичная	стабилизация	прогрессирование
Основная 8 пациентов	-	6 (75%)	2(25%)	-

Результаты

В большинстве случаев ХТТ проходила без выраженных побочных явлений, которые не лимитировали намеченный курс лечения. Проявление токсичности III и IV степени мы не отмечали ни у одного больного, а наблюдаемые побочные явления были ожидаемыми (таблица 3).

В качестве критериев оценки непосредственных результатов лечения больных раком прямой кишки избраны общепринятые показатели: частота и структура послеоперационных осложнений и летальности (табл. 4). В структуре ранних послеоперационных осложнений преобладали гнойно-воспалительные процессы. Послеоперационной летальности при хирургическом лечении больных раком прямой кишки в обеих группах не было. Опасения риска кровотечения в интра- и постоперационном периоде не подтвердились, повышенной кровоточивости тканей во время и после операции не было.

Характерными для химиотаргетной терапии побочными действиями, связанными, по всей вероятности, с применением авастина, были боли в эпигастрии, проявившиеся в 62,5% случаев, легко купировавшиеся назначением симптоматической терапии. При эндоскопическом исследовании желудка у этих пациентов обнаруживалась картина гастрита, без геморрагий.

Оценка результатов лечения проводилась по субъективным и объективным критериям.

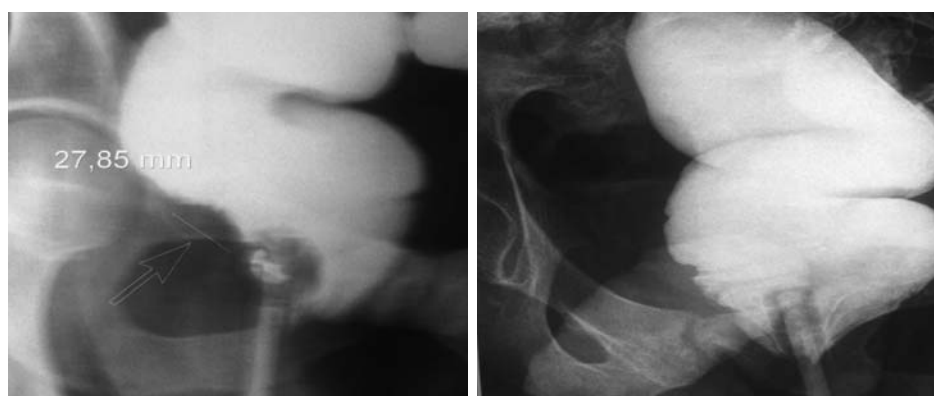


Рисунок 1- Рентгенологическая картина до- и после предоперационной терапии

При контрольном рентген-эндоскопическом исследовании установлено, что частичная регрессия достигнута в 6 (75%) случаях, стабилизация – 2 (25%), прогрессирования не было (таблица 5).

На рисунке 1 представлен пример рентген-картины регрессии опухоли после ХТТ рака прямой кишки в предоперационном периоде.

Заключение и выводы

Использованный режим химиотаргетной терапии (FOLFIRI+бевацизумаб) позволил достичь непосредственного результата в виде частичной регрессии в 6 (75%) случаях и стабилизации – в 2 (25%).

Методика неoadъювантной химиотаргетной терапии позволяет сократить на 40-45 дней длительность предоперационного лечения по сравнению с проводимой ранее неoadъювантной химиолучевой терапией (80-85 дней), при этом, сохраняется его эффективность.

Применение таргетного ангиоингибирующего препарата бевацизумаба во время неoadъювантной химиотерапии повышает частоту обострений гастрита и язвенной болезни, без геморрагии, но с болевым синдромом легкой и средней степени тяжести до 62,5%.

Список литературы

1. Charles Erlichman, and Daniel J. Sargent. New Treatment Options for Colorectal Cancer //NEJM. – 2004. – V.351. – P. 391-392.
2. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2007 г. //Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. – 2009. – Т.20. – Прилож. №1. – 150 с.
3. Samaranayake H., Määttä A.M., Pikkarainen J., Yla-Herttuala S. Future prospects and challenges of anti-angiogenic cancer gene therapy //Hum. Gene Ther. -2010.- Feb 17. Abstract. Pubmed
4. Lièvre F., Samalin E. Bevacizumab plus FOLFIRI or FOLFOX in

chemotherapy-refractory patients with metastatic colorectal cancer: a retrospective study //BMC Cancer.-2009.-Vol.28, N9.-P.347. Abstract. 1.

Тұжырым

А.К.Туманова, М.А.Кузикеєв, С.Е. Есентаєва, С.В.Лаикул, А.И.Джуманов

Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институты

Тік ішек қатерлі ісігінің неoadъювантты химиотаргетті терапиясының тиімділігін байқауының кезеңдік нәтижелері осы жұмыс тік ішек обырын емдеудің неoadъювантты кезеңінде таргетті агенттердің маңызын зерттеуге арналған. Иринотекан+натрий фоллинат/фторурацилді, бевацизумаб препараттарының тікелей әсер етуі және химиотаргетті терапияның жанама әсері туралы аралық мәліметтер алынған.

Түйінді сөздер: тік ішек рагы, химио-таргетті терапия.

Summary

Tumanova A.K., Kuzikeev M.A., Yesentayeva S.E., Lashkul S.V., Djumanov A.I.

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Interim results of efficiency neoadjuvant chemo-targeted therapy for rectal cancer

This research study aims to the role of the targeted agent in pre-operative treatment of the rectal cancer. Received intermediate data of the immediate effectiveness and side effects of the chemotargeted therapy based on: irinotecan, fluorouracil/ sodium folinate, bevacizumab.

Key words: colorectal cancer, chemo-therapy targeted